ICS 11 .020

C 05

广东省针灸学会团体标准

【T/GDZJ XXXX-202X】

岭南特色针灸技术操作规范：精灸技术

Standardized manipulations of Lingnan characteristic acupuncture and moxibustion: Refined Moxibustion

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布　　XXXX-XX-XX 实施

广东省针灸学会 发布

前言

《岭南特色针灸技术操作规范》共包含以下 5 个部分：

——精灸技术

——岭南传统天灸技术

——灵龟灸法技术

——司徒氏针挑技术

——岭南火针技术

本部分为第 1 部分【**T/GDZJ XXXX-202X**】

本部分按照 GB/T 1.1-2020、GB/T 1.2-2020 与 GB/T 33416-2016 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由广东省针灸学会提出

本部分由广东省针灸学会归口

本部分起草单位：广东省中医院、深圳市宝安区中医院、海南省中医院、浙江省中医院、海口市中医院、广东梅州中医院

本部分主要起草人：符文彬

本部分参加起草人：吴倩、马瑞、周鹏、阎路达、李薇晗、张光彩、黄小珊、姜硕、王丽娟、陈鸣、牛淑芳、颜洪亮

引言

精灸是岭南针灸名家符文彬教授在继承岭南针灸大师司徒铃教授灸法的基础上，对艾草选用、艾绒加工、艾炷制作等环节深入研究，不断完善理论基础和技术操作，创新发展而成。因其热力集中、透热迅速、耗时短、刺激量大，一壮可达到普通麦粒灸 2～3 壮之效，术精而效验，故得其名。

目前精灸已在临床上广泛应用于痛证、失眠及抑郁相关病症等疾病，已推广至广东、海南、广西、浙江、港澳等全国十余个省市及东南亚等海外地区，故制定本技术操作的标准性文件，以利于岭南特色针灸技术操作的规范，以及针灸同仁的学习与运用。

1 范围

本部分规定了精灸的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本部分适用于精灸技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T12346 腧穴名称与定位

GB/T 21709.1-2008 针灸技术操作规范 第 1 部分 艾灸

3 术语和定义

3.1 精灸

将以精细艾绒为材料制成小米粒大小的艾柱，置于穴位或病变部位处点燃的一种直接灸技术。

3.2 精细艾绒

细软金黄的陈年艾绒。具有便于搓捻成小规格艾柱，燃烧时火力均匀、气味芬芳等特点。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 灸材选择

选择合适的精细艾绒，检查艾绒有无霉变、潮湿。

准备好用于增加艾柱粘着性或具有消肿止痛作用的液性药物，如万花油。

准备好线香、打火机等点火工具以及治疗盘、弯盘、棉签、镊子等辅助工具。

4.1.2 穴位的选择与定位

根据病症选取适当的穴位或治疗部位。穴位定位应符合 GB/T12346 的规定。

4.1.3 体位的选择

选择患者舒适、医者便于操作的治疗体位。

4.1.4 环境的要求

应注意环境清洁卫生，避免污染。

4.2 施术方法

4.2.1 涂抹精灸的介质

以棉签沾取万花油涂在穴位或施术部位上。

4.2.2 制作艾柱

取适量精细艾绒，用手工或器具制成底面直径为 2mm，高 3mm 的圆锥形艾柱。

4.2.3 点燃艾柱

将艾柱置于穴位或施术部位上，用线香点燃艾柱上头。

4.2.4 控制灸度和灸量

根据患者病情轻重及耐受力，选用合适的艾灸量。

4.2.5 移去与更换艾柱

艾柱燃烧过半，皮肤潮红、灼痛时，术者用手指或镊子迅速移去艾柱；或术者用手在施灸穴位的周围轻轻拍打或抓挠，以分散患者注意力，减轻施灸时的痛苦，直至艾柱燃毕。

可根据需要更换艾炷，连续灸足应灸的壮数。

4.3 施术后处理

灸后注意保持局部皮肤清洁干燥，无需特殊护理。

施灸后处理还应符合 GB/T 21709.1-2008 的相关规定。

5 注意事项

5.1 施灸前应告知患者该技术的治疗目的及简单操作过程，并征得患者同意。

5.2 制备艾柱时应注意控制艾柱的大小，过大的艾柱在施灸时易造成皮肤灼伤。

5.3 发泡后局部灸疮当日勿沾水，预防感染。

5.4 幼儿患者皮肤稚嫩，应注意控制艾灸量。

5.5 注意防止线香灰烬掉落而烫伤皮肤或烧坏衣被，治疗结束应及时熄灭线香。

5.6 患者在接受精灸治疗时一般不会发生晕灸现象；如发生晕灸现象，应按照GB/T 21709.1-2008 的相关规定进行处理。

6 禁忌

6.1 颜面、心前区、大血管部和关节、肌腱处不可用瘢痕灸；乳头、外生殖器官不宜施灸。

6.2 中暑、高血压危象、肺结核晚期大量咯血、高热炎性疾病、局部疮疡等情况不宜施灸；糖尿病血糖控制欠佳者的肢端处、脑出血急性期者慎用精灸。

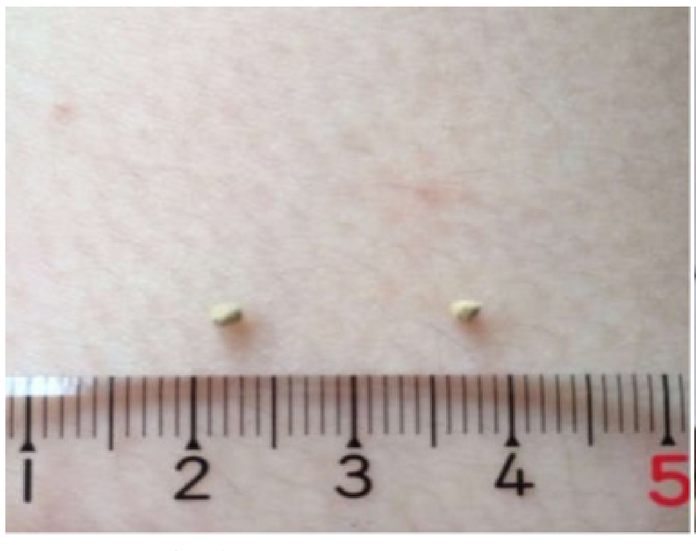
6.3 孕妇腹部与腰骶部不宜施灸。

附录

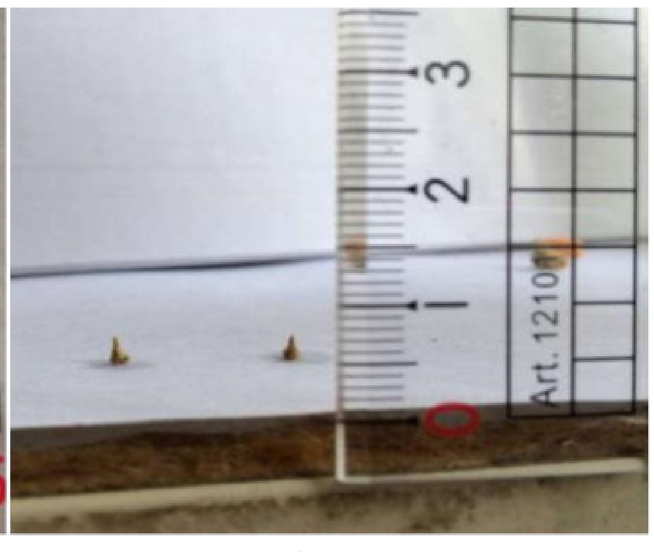
附录 A

（资料性附录）

精灸艾灸柱规格图例



底直径 2mm



高 3mm

附录 B

（资料性附录）

艾灸量的区分

应根据施灸部位、病情以及患者耐受程度把握精灸的艾灸量、时间和疗程。

一般情况下，精灸治疗频次为 2 ～ 3 次/周，每次精灸的灸量为 1-3 壮，每壮燃烧 3 ～5 秒。轻度疾病可行 1 壮，艾炷燃到 1/2，或灸至局部皮肤红晕为度；中度疾病可行 2 壮，艾炷燃到 2/3，或灸至穴位皮肤潮红为度；重度疾病可行 3 壮或以上，艾炷燃尽，灸至穴位皮肤发白或轻微发泡为度。

附录 C

（资料性附录）

临床适应症

根据前期文献与临床调研，列举如下精灸适应症：

1.痛症：头痛、颈痛、面痛、肩痛、腕管综合征、腰椎间盘突出症、膝骨性关节炎、痛风性关节炎、痛经、产后身痛等；

2.脑病：中风、眩晕、面瘫、面肌痉挛、失眠、抑郁、焦虑、帕金森病、小脑共济失调、慢性疲劳综合征等；

3.肝胆脾胃病症：呕吐、呃逆、消化不良、肠易激综合征、慢性胃炎等；

4.肺系及过敏病症：哮喘、支气管炎、过敏性咳嗽、过敏性鼻炎、荨麻疹等；

5.代谢内分泌疾病：肥胖症、高血脂症、高尿酸血症、糖耐量异常等；

6.妇儿病症：月经病、围绝经期综合征、子宫肌瘤、多囊卵巢综合征、妇科恶性肿瘤术后或放化疗后调理、小儿抽动障碍、小儿遗尿、小儿发育不良等；

7.养生保健：预防中风、调节血压、美容等。